Simulados de Pediatria

Duas provas completas de 30 questões (A, B, C, D) no formato da somativa de SCA, com gabarito comentado

Como usar

Este arquivo traz **duas provas inéditas de 30 questões**, diferentes do simulado que está no fim da masterclass. Cada prova reproduz a distribuição informada pela turma:

Tema	Questões por prova	Simulado A	Simulado B
Diarreia (planos de hidratação)	2	1, 2	1, 2
Asma (fácil)	1	3	3
Urgência isolada	1	4	4
Urgência dentro das doenças	1	5	5
Adolescência e puberdade	6	6 a 11	6 a 11
Hepatoesplenomegalia (fácil, média, difícil)	3	12, 13, 14	12, 13, 14
IVAS (uma isolada, uma com otite)	2	15, 16	15, 16
Meningite	2	17, 18	17, 18
Doenças de pele	2	19, 20	19, 20
Exantemáticas (uma com esplenomegalia)	2	21, 22	21, 22
Bronquiolite e coqueluche	2	23, 24	23, 24
Pneumonia	1	25	25
Hemograma misturado	2	26, 30	26, 30
Prescrição e complementares	3	27 a 29	27 a 29

Regras sugeridas. Faça cada prova de uma vez, em até 60 minutos, sem consultar material. Marque as respostas na folha abaixo. Só então abra o gabarito, que está em página separada. Cada comentário indica o capítulo da masterclass para revisão.

Siglas usadas nas questões: SRO (solução de reidratação oral), TEC (tempo de enchimento capilar), FC (frequência cardíaca), FR (frequência respiratória), PA (pressão arterial), SatO2 (saturação periférica de oxigênio), LCR (líquido cefalorraquidiano), IO (idade óssea), RCD (rebordo costal direito), Hb (hemoglobina), LH (hormônio luteinizante), FSH (hormônio folículo-estimulante), GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas), OMA (otite média aguda), IVAS (infecções de vias aéreas superiores).

Folha de respostas

Questão	Simulado A	Simulado B	Questão	Simulado A	Simulado B
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		

Questão	Simulado A	Simulado B	Questão	Simulado A	Simulado B
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

Simulado A

1. (Diarreia) Pré-escolar de 3 anos, 14 kg, com diarreia aquosa e vômitos há 2 dias. Chega letárgico, com olhos fundos, mucosa muito seca, incapaz de beber, sinal da prega desaparecendo em mais de 2 segundos e pulso fraco. A prescrição inicial correta é:

A. SRO 700 a 1.400 mL em 4 a 6 horas, na unidade de saúde.
B. Soro fisiológico 0,9%, 420 mL em 1 hora, seguido de 980 mL em 5 horas.
C. Soro fisiológico 0,9%, 420 mL em 30 minutos, seguido de 980 mL em 2 horas e 30 minutos.
D. Soro glicosado 5% com soro fisiológico 4:1, 1.200 mL em 24 horas.

2. (Diarreia) Analise as afirmativas sobre a diarreia aguda na criança:

I. Para uma criança de 2 anos, o zinco é prescrito na dose de 20 mg/dia por 10 a 14 dias.

II. Diarreia com sangue, muco, febre e cólica caracteriza o fenótipo inflamatório.

III. O aleitamento materno deve ser suspenso até a melhora da diarreia, para reduzir a carga osmótica.

IV. No Plano A, uma criança de 3 anos deve receber de 100 a 200 mL de líquido após cada evacuação.

Quantas estão corretas?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. (Asma, fácil) Escolar de 7 anos, asmático, chega ao pronto atendimento com tosse e sibilos, falando frases completas, sem uso de musculatura acessória, FC de 110 bpm e SatO2 de 94%. A conduta inicial mais adequada é:

A. Sulfato de magnésio endovenoso como primeira medida.
B. Salbutamol em aerossol dosimetrado com espaçador, repetido na primeira hora, e corticoide oral.
C. Amoxicilina, pois a crise asmática é desencadeada por infecção bacteriana.
D. Salmeterol isolado, por ter ação prolongada.

4. (Urgência isolada) Na abordagem da criança potencialmente grave, a impressão inicial é feita antes de tocar no paciente. Ela avalia:

A. Aparência e consciência, padrão respiratório e cor ou perfusão da pele.
B. Pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia capilar.
C. Sinais e sintomas, alergias, medicamentos, passado médico, última refeição e eventos.
D. Pulsos centrais, TEC e pressão arterial.

5. (Urgência dentro das doenças) Escolar de 8 anos em crise asmática fala apenas palavras soltas, está sonolento, com SatO2 de 86% e ausculta com murmúrio quase inaudível, sem sibilos. Já recebeu salbutamol seriado, brometo de ipratrópio e metilprednisolona, sem melhora. A próxima medida farmacológica indicada é:

A. Suspender o salbutamol, porque os sibilos desapareceram.
B. Prescrever amoxicilina com clavulanato.
C. Iniciar montelucaste oral.
D. Sulfato de magnésio de 25 a 75 mg/kg (máximo de 2 g), endovenoso, em 20 a 30 minutos.

6. (Adolescência) Adolescente de 16 anos, menarca há 3 anos, com ciclos regulares, apresenta cólica intensa nos dois primeiros dias de cada menstruação, sem outros sintomas e com exame físico normal. A abordagem inicial de eleição é:

A. Ultrassonografia transvaginal antes de qualquer tratamento.
B. Anti-inflamatório não esteroide, para analgesia e redução do fluxo.
C. Encaminhamento imediato para videolaparoscopia.
D. Antibiótico para doença inflamatória pélvica.

7. (Puberdade e crescimento) Menina de 9 anos. Pai com 180 cm e mãe com 160 cm. A estatura alvo e o canal esperado, segundo a fórmula da aula, são:

A. 176,5 cm, entre 168 e 185 cm.
B. 170 cm, entre 161,5 e 178,5 cm.
C. 157 cm, entre 148,5 e 165,5 cm.
D. 163,5 cm, entre 155 e 172 cm.

8. (Puberdade) Ao exame de uma menina, observa-se projeção da aréola e da papila formando um segundo monte acima do nível da mama. Pelo estadiamento de Tanner, ela está em:

A. M2.
B. M3.
C. M4.
D. M5.

9. (Puberdade precoce) Menina de 6 anos com broto mamário bilateral e pelos pubianos há 5 meses, velocidade de crescimento aumentada, relação LH/FSH acima de 1, idade óssea de 8 anos e ultrassonografia com útero e ovários aumentados. Sobre o caso, é correto afirmar:

A. Trata-se de puberdade precoce central, provavelmente idiopática, e o tratamento indicado é o análogo de GnRH.
B. Trata-se de puberdade precoce periférica, e o análogo de GnRH está contraindicado.
C. Não é puberdade precoce, pois o limite nas meninas é de 6 anos.
D. A causa mais provável é tumor do sistema nervoso central, como ocorre em 2/3 das meninas.

10. (Adolescência) Adolescente de 15 anos é levada à consulta por cortes superficiais e paralelos no antebraço. Refere que se corta “para aliviar a tensão” e nega desejo de morrer. A conduta mais adequada é:

A. Explicar à família que se trata de comportamento para chamar atenção e que deve ser ignorado.
B. Acolher sem julgamentos, avaliar o risco de suicídio e envolver equipe multidisciplinar.
C. Encaminhar o caso apenas ao conselho tutelar, sem seguimento médico.
D. Prescrever benzodiazepínico e dar alta.

11. (Crescimento) Menino de 10 anos com estatura no percentil 3, velocidade de crescimento normal e constante, idade óssea igual à idade cronológica, exame físico normal e pais baixos (estatura alvo no percentil 3). O diagnóstico e a conduta são:

A. Deficiência de hormônio do crescimento; iniciar somatropina.
B. Atraso constitucional do crescimento e da puberdade; aguardar o estirão tardio.
C. Hipotireoidismo; iniciar levotiroxina.
D. Baixa estatura familiar; acompanhar o crescimento e tranquilizar a família.

12. (Hepatoesplenomegalia, fácil) Qual dos achados abaixo deve ser considerado anormal?

A. Lactente de 4 meses com fígado palpável a 2 cm do RCD.
B. Recém-nascido com ponta de baço palpável.
C. Adolescente de 12 anos com fígado palpável a 3 cm do RCD.
D. Criança de 3 anos com fígado palpável a 1,5 cm do RCD, borda fina e indolor.

13. (Hepatoesplenomegalia, média) Criança de 3 anos que brinca em caixa de areia e convive com filhotes de cães apresenta febre baixa, tosse com sibilância, hepatomegalia e esplenomegalia discreta. Hemograma com leucocitose e eosinofilia de 40%. A hipótese mais provável é:

A. Leucemia linfoide aguda.
B. Toxocaríase.
C. Mononucleose infecciosa.
D. Doença de Gaucher.

14. (Hepatoesplenomegalia, difícil) Adolescente de 13 anos com hepatoesplenomegalia, queda do rendimento escolar, tremor e alteração de comportamento. Transaminases discretamente elevadas. Ao exame oftalmológico com lâmpada de fenda, há anel acastanhado na periferia da córnea. Os exames da propedêutica sequencial que confirmam a principal hipótese são:

A. Ceruloplasmina sérica e cobre na urina de 24 horas.
B. Alfa-fetoproteína e ferritina.
C. Teste do suor e quimiotripsina fecal.
D. Sorologias TORCHS e teste tuberculínico.

15. (IVAS isolada) Escolar de 8 anos com faringoamigdalite estreptocócica confirmada por teste rápido. A mãe relata que, aos 4 anos, apresentou exantema leve após uso de amoxicilina, sem acometimento de vias aéreas. A opção terapêutica adequada é:

A. Penicilina G benzatina, pois a reação foi leve.
B. Amoxicilina com clavulanato por 10 dias.
C. Azitromicina por 3 dias.
D. Cefalexina por 10 dias.

16. (IVAS com otite) Criança de 3 anos com coriza, tosse, hiperemia de orofaringe sem exsudato e febre de 38,3 °C. Otoscopia com membrana timpânica direita abaulada, sem otorreia; esquerda normal. Bom estado geral, otalgia há 24 horas e seguimento garantido. A conduta mais adequada é:

A. Penicilina G benzatina para a faringite e amoxicilina para a otite.
B. Amoxicilina com clavulanato em dose dobrada por 10 dias.

C. Sintomáticos e observação, com reavaliação se a febre ou a otalgia persistirem por mais de 48 a 72 horas.
D. Ceftriaxona intramuscular por 3 dias.

17. (Meningite) Recém-nascido de 10 dias com febre, recusa alimentar e fontanela abaulada. LCR turvo com predomínio de neutrófilos. O esquema empírico adequado é:

A. Ceftriaxona isolada.
B. Ampicilina associada a gentamicina (ou a cefotaxima).
C. Vancomicina isolada.
D. Aciclovir isolado.

18. (Meningite) Pré-escolar de 3 anos internado com meningite por *Haemophilus influenzae* tipo b. Em casa vivem os pais e um irmão de 2 anos com vacinação atrasada (não recebeu a vacina penta). Na creche, este é o primeiro caso em 60 dias. A conduta para os contatos é:

A. Rifampicina para todos os contatos domiciliares, pois há criança abaixo de 4 anos não vacinada; na creche, não há indicação.
B. Rifampicina apenas para o irmão.
C. Rifampicina para todos os contatos da creche e do domicílio.
D. Não há indicação de quimioprofilaxia para *Haemophilus*.

19. (Pele) Recém-nascido de 3 dias, a termo, em bom estado geral, com pápulas esbranquiçadas circundadas por halo eritematoso e edematoso, semelhantes a picadas de inseto, no tronco e nos membros, poupando palmas e plantas. A conduta é:

A. Colher hemocultura e iniciar oxacilina.
B. Aplicar mupirocina nas lesões.
C. Tranquilizar a família, pois é eritema tóxico, benigno e autolimitado.
D. Prescrever permetrina 5%.

20. (Pele) Criança de 6 anos com febre alta, calafrios e placa eritemato-edematosa dolorosa, de bordas bem delimitadas, na face, com adenopatia regional. Sobre o tratamento, assinale a correta:

A. Penicilina G benzatina em dose única é a escolha.
B. Mupirocina tópica é suficiente.
C. Por ser infecção do subcutâneo de limites imprecisos, deve-se pensar em *H. influenzae*.
D. Penicilina G cristalina ou ampicilina são opções, e a penicilina benzatina não deve ser usada.

21. (Exantemática com esplenomegalia) Adolescente de 16 anos com febre, fadiga, amigdalite membranosa, adenomegalia cervical e generalizada, e baço palpável. Recebeu amoxicilina e desenvolveu exantema máculo-papular difuso. Sobre o caso, assinale a correta:

A. O exantema confirma alergia permanente às penicilinas, e todas devem ser proscritas.
B. O exantema após amoxicilina ocorre em 80 a 100% dos pacientes com mononucleose, e o hemograma deve mostrar linfócitos atípicos acima de 20%.
C. A incubação é de 7 a 14 dias, como nas demais viroses.
D. O tratamento de escolha é a penicilina G benzatina.

22. (Exantemática) Escolar de 7 anos com febre, dor de garganta e vômitos há 1 dia. Ao exame: amígdalas com placas, petéquias no palato, exantema áspero ao toque que começou no pescoço e nas axilas, palidez ao redor da boca e acentuação da cor nas dobras dos cotovelos. Assinale a correta:

A. O antibiótico previne a febre reumática, mas não previne a glomerulonefrite difusa aguda.
B. A palidez perioral é o sinal de Pastia, e a acentuação nas dobras é o sinal de Filatov.
C. O agente é o parvovírus B19.
D. O tratamento é apenas sintomático.

23. (Bronquiolite) Prematuro nascido com 27 semanas, hoje com 3 meses, na véspera do outono. A medida preventiva contra o vírus sincicial respiratório disponível no SUS para ele é:

A. Vacina aplicada no próprio lactente aos 2 e 4 meses.
B. Ribavirina profilática mensal.
C. Palivizumabe 15 mg/kg intramuscular, uma vez por mês durante a sazonalidade (5 doses).
D. Azitromicina profilática semanal.

24. (Coqueluche) Lactente de 2 meses internado com coqueluche confirmada. Sobre a prevenção, assinale a correta:

A. A precaução para gotículas pode ser suspensa 24 horas após o início do antibiótico.
B. A quimioprofilaxia é indicada apenas para contatos com sintomas.
C. A vacina dTpa deve ser feita na gestante apenas na primeira gestação.
D. Os contatos domiciliares devem receber quimioprofilaxia com o mesmo esquema do tratamento, e a gestante deve receber dTpa a partir da 20ª semana em todas as gestações.

25. (Pneumonia) Criança de 3 anos com febre de 38,8 °C há 2 dias, tosse e FR de 46 irpm. Ausculta com crepitações em base direita. Sem tiragem subcostal, SatO2 de 96%, aceitando líquidos, bom estado geral, contexto social adequado. A conduta é:

A. Internação e ampicilina endovenosa.
B. Amoxicilina 50 mg/kg/dia por via oral, com reavaliação em 48 a 72 horas, sem radiografia de rotina.
C. Radiografia de tórax obrigatória antes de qualquer tratamento.
D. Azitromicina por 5 dias, pois é a primeira escolha nessa idade.

26. (Hemograma misturado) Escolar de 9 anos, afebril, atendido por crise asmática, recebeu adrenalina e corticoide sistêmico. Hemograma 4 horas depois: 18.000 leucócitos com 82% de neutrófilos, sem bastões, sem granulação tóxica. A interpretação adequada é:

A. Infecção bacteriana grave; iniciar antibiótico de amplo espectro.
B. Reação leucemoide; solicitar mielograma.
C. Neutrofilia provavelmente secundária aos medicamentos; não indica antibiótico por si só.
D. Leucemia mieloide crônica.

27. (Prescrição) Criança de 20 kg com indicação de azitromicina suspensão 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia. A prescrição correta é:

A. 5 mL, uma vez ao dia, por 5 dias, uma hora antes ou duas horas após a alimentação.
B. 20 mL, uma vez ao dia, por 5 dias, junto com as refeições.

C. 2,5 mL de 12 em 12 horas, por 10 dias.

D. 10 mL, uma vez ao dia, por 3 dias.

28. (Pneumonia complicada) Criança internada com pneumonia mantém febre após 72 horas de antibiótico. A ultrassonografia mostra derrame pleural, e a toracocentese revela líquido turvo com pH de 7,0, glicose de 30 mg/dL e LDH de 1.500 UI. A conduta é:

A. Manter o mesmo antibiótico e repetir a radiografia em 7 dias.

B. Suspender o antibiótico, pois se trata de derrame estéril.

C. Iniciar corticoide sistêmico.

D. Drenagem pleural associada ao antibiótico.

29. (Farmacodermia) Criança de 5 anos iniciou anticonvulsivante há 3 semanas e apresenta febre, lesões em alvo, erosões em lábios, mucosa oral e conjuntivas, com descolamento de cerca de 8% da superfície corporal. O diagnóstico e a medida inicial são:

A. Eritema infeccioso; sintomáticos.

B. Síndrome de Stevens-Johnson; suspender o medicamento e considerar imunoglobulina.

C. Necrólise epidérmica tóxica; manter o anticonvulsivante e associar corticoide tópico.

D. Varicela; aciclovir.

30. (Hemograma) Lactente de 10 meses com infecções de repetição. Hemograma: 3.000 leucócitos, com 20% de segmentados e 0% de bastões. A contagem absoluta de neutrófilos e a classificação são:

A. 3.000 por mm^3; normal.

B. 300 por mm^3; neutropenia grave.

C. 600 por mm^3; neutropenia moderada.

D. 1.200 por mm^3; neutropenia leve.

Gabarito comentado do Simulado A

1 C	2 C	3 B	4 A	5 D	6 B	7 D	8 C	9 A	10 B
11 D	12 C	13 B	14 A	15 D	16 C	17 B	18 A	19 C	20 D
21 B	22 A	23 C	24 D	25 B	26 C	27 A	28 D	29 B	30 C

1. **C.** Letárgico, não bebe e pulso fraco são os três sinais com asterisco: Plano C. A partir de 1 ano: 30 mL/kg em 30 minutos (420 mL) e 70 mL/kg em 2 h 30 (980 mL). A alternativa B é o tempo do menor de 1 ano; D é a fase de manutenção, não a expansão. (Capítulo 8)
2. **C.** I, II e IV corretas. III errada: não se suspende o leite materno nem a alimentação. (Capítulo 8)
3. **B.** Crise leve a moderada: SABA com espaçador seriado na 1ª hora e corticoide oral (prednisolona 1 a 2 mg/kg/dia, máximo de 40 mg, por 3 a 5 dias). Magnésio é para crise grave refratária; LABA nunca isolado. (Capítulo 6)
4. **A.** O triângulo da impressão inicial: aparência, respiração e cor ou perfusão. C é o SAMPLE (avaliação secundária); B e D pertencem ao ABCDE. (Capítulo 7)
5. **D.** Tórax silencioso e sonolência indicam ameaça à vida; sem resposta à 1ª linha, sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg (máximo 2 g) EV lento. O desaparecimento dos sibilos significa ausência de fluxo, não melhora. (Capítulos 6 e 14)
6. **B.** Dismenorreia primária de ciclos ovulatórios: AINE é a abordagem inicial de eleição (reduz prostaglandinas, dor e fluxo). (Capítulo 13)
7. **D.** Menina: (180 menos 13 mais 160) ÷ 2 = 327 ÷ 2 = 163,5 cm; canal de mais ou menos 8,5 cm, de 155 a 172 cm. A alternativa A usou a fórmula masculina. (Capítulo 13)
8. **C.** O “segundo monte” define M4. M2 é o broto; M3 aumenta mama e aréola sem separar contornos; M5 só a papila se projeta. (Capítulo 13)
9. **A.** Antes dos 8 anos, harmônica, LH/FSH acima de 1, idade óssea avançada em 2 anos e útero e ovários aumentados: central. Nas meninas predomina a forma idiopática; tratar com análogo de GnRH. Os 2/3 com lesão do SNC referem-se aos meninos. (Capítulo 13)
10. **B.** Automutilação para alívio de tensão, habitualmente sem intenção suicida: acolhimento sem julgamento, equipe multidisciplinar e sempre avaliar o risco de suicídio. (Capítulo 13)
11. **D.** Alvo genético baixo, idade óssea igual à cronológica e velocidade normal: baixa estatura familiar. No atraso constitucional, a idade óssea estaria atrasada e o alvo seria normal. (Capítulo 13)
12. **C.** Acima de 10 anos, o fígado não deve ser palpável. Os demais achados são normais para a idade. (Capítulo 10)
13. **B.** Contato com cães (filhotes) e areia, hepatomegalia, sintomas respiratórios e eosinofilia intensa: toxocaríase. (Capítulo 10)
14. **A.** Hepatopatia com sintomas neurológicos e anel de Kayser-Fleischer: doença de Wilson; confirmar com ceruloplasmina e cobre urinário de 24 horas. (Capítulo 10)
15. **D.** Alergia leve a moderada à penicilina: cefalexina (2ª escolha) por 10 dias. Azitromicina fica para alergia grave e é feita por 5 dias. (Capítulo 3)
16. **C.** A faringite tem sinais virais (coriza, tosse, sem exsudato). Na OMA unilateral sem otorreia acima de 2 anos, sem febre acima de 39 °C, sem toxemia, com otalgia abaixo de 48 horas e seguimento garantido, a tabela é favorável à observação. (Capítulo 3)

17. **B.** No RN é preciso cobrir *Listeria*, *E. coli* e estreptococo do grupo B: ampicilina com gentamicina ou cefotaxima. Ceftriaxona é contraindicada abaixo de 28 dias. (Capítulo 9)
18. **A.** No Hib, a quimioprofilaxia domiciliar é indicada quando há criança abaixo de 4 anos não vacinada ou imunocomprometida, e então se estende a todos do domicílio; na creche, só com 2 casos em 60 dias. (Capítulo 9)
19. **C.** Eritema tóxico: 3º a 4º dia, pápulas com halo eritematoso, poupa palmas e plantas, estéril, assintomático, sem tratamento. (Capítulo 12)
20. **D.** Erisipela (placa bem delimitada, febre alta, face na criança): penicilina G cristalina ou ampicilina; a aula destaca não usar benzatina. A alternativa C descreve celulite. (Capítulo 12)
21. **B.** Mononucleose: exantema em 3 a 8% espontaneamente e em 80 a 100% se receber penicilina ou amoxicilina; linfócitos atípicos acima de 20%; incubação de 30 a 50 dias. (Capítulos 10 e 11)
22. **A.** Escarlatina: o antibiótico previne a febre reumática, mas não a GNDA. Os nomes estão trocados na alternativa B: Filatov é a palidez perioral e Pastia, a acentuação nas dobras. (Capítulo 11)
23. **C.** Prematuro abaixo de 29 semanas no 1º ano: palivizumabe 15 mg/kg IM mensal, 5 doses na sazonalidade. A vacina contra o VSR é aplicada na gestante. (Capítulo 5)
24. **D.** Quimioprofilaxia dos contatos domiciliares com o mesmo esquema do tratamento; dTpa a partir da 20ª semana em todas as gestações. A precaução dura 5 dias após o início do antibiótico efetivo (ou 3 semanas do início da fase paroxística). (Capítulo 5)
25. **B.** Taquipneia (40 ou mais de 1 a 5 anos) sem sinais de perigo: tratamento ambulatorial com amoxicilina 50 mg/kg/dia e reavaliação em 48 a 72 horas; radiografia não é de rotina. Azitromicina é para atípica, mais comum acima de 5 anos. (Capítulo 4)
26. **C.** Adrenalina e corticoide causam neutrofilia por desmarginação, sem infecção; reação leucemoide exige mais de 50.000 leucócitos com desvio. (Capítulos 1 e 14)
27. **A.** 10 mg/kg × 20 kg = 200 mg = 5 mL (40 mg/mL); uma vez ao dia, por 5 dias, em jejum. A regra de 1 mL por kg não vale para a azitromicina. (Capítulo 2)
28. **D.** pH abaixo de 7,1, glicose abaixo de 40 mg/dL e LDH acima de 1.000 UI indicam invasão bacteriana: drenagem mais antibiótico. (Capítulo 4)
29. **B.** Descolamento abaixo de 10% da superfície com 2 ou mais mucosas: Stevens-Johnson; anticonvulsivantes estão entre os principais agentes; suspender a droga e considerar imunoglobulina. NET seria acima de 30%. (Capítulo 11)
30. **C.** 3.000 × 20% = 600 por mm^3: neutropenia moderada (500 a 1.000). (Capítulo 1)

Simulado B

1. (Diarreia) Criança de 2 anos, 12 kg, classificada como “com desidratação”, recebeu SRO por 4 horas na unidade. Na reavaliação, está alerta, aceita líquidos, mas mantém olhos fundos e mucosa seca, sem sinais de gravidade. A conduta é:

A. Manter a reidratação no serviço, considerando SRO por sonda nasogástrica (gastróclise) se não conseguir ingerir o volume necessário.
B. Alta com Plano A, pois já se passaram 4 horas.
C. Iniciar Plano C imediatamente.
D. Suspender a SRO e iniciar antidiarreico.

2. (Diarreia) Lactente de 8 meses, 7 kg, comatoso, com pulso fraco e TEC de 5 segundos após 3 dias de diarreia. A fase de expansão do Plano C deve ser:

A. Soro fisiológico 140 mL em 20 minutos, repetido até três vezes.
B. Soro fisiológico 210 mL em 30 minutos e 490 mL em 2 horas e 30 minutos.
C. SRO 700 mL em 4 a 6 horas.
D. Soro fisiológico 210 mL em 1 hora e 490 mL em 5 horas.

3. (Asma, fácil) Para o diagnóstico de asma em uma criança de 4 anos, segundo o GINA, é necessário:

A. Espirometria com prova broncodilatadora positiva.
B. Apenas um episódio de sibilância em vigência de infecção viral.
C. Sibilância recorrente, ausência de causa alternativa provável e resposta clínica ao tratamento.
D. Dosagem de IgE total elevada.

4. (Urgência isolada) Na avaliação primária ABCDE de uma criança sonolenta, a glicemia capilar deve ser verificada na etapa:

A. A, junto com a via aérea.
B. D, na avaliação neurológica.
C. E, na exposição.
D. Somente após a história SAMPLE.

5. (Urgência dentro das doenças) Escolar de 7 anos com suspeita de meningite bacteriana apresenta papiledema, bradicardia, hipertensão arterial e respiração irregular. A conduta correta é:

A. Iniciar antibiótico empírico e solicitar tomografia de crânio antes de realizar a punção lombar.
B. Realizar punção lombar imediatamente, pois o líquor é indispensável antes do antibiótico.
C. Aguardar a tomografia para só então iniciar o antibiótico.
D. Dar alta com antitérmico e retorno em 24 horas.

6. (Adolescência) Adolescente de 15 anos comparece sozinho à consulta, pede sigilo sobre o início da vida sexual e demonstra compreender riscos e consequências de suas escolhas. Não há situação de risco à vida. A conduta adequada é:

A. Comunicar os pais, pois o paciente é menor de idade.

B. Recusar o atendimento sem a presença de um responsável.
C. Manter o sigilo, orientar sobre prevenção e recomendar o preservativo, que é o único método que protege contra infecções sexualmente transmissíveis.
D. Prescrever contraceptivo apenas com autorização judicial.

7. (Adolescência) Adolescente de 13 anos com obesidade queixa-se de "seios aumentados". À palpação, há aumento mole e difuso da região mamária, sem disco glandular subareolar. O diagnóstico é:

A. Ginecomastia puberal fisiológica.
B. Lipomastia (pseudoginecomastia).
C. Ginecomastia por tumor testicular.
D. Macroginecomastia com indicação cirúrgica.

8. (Adolescência) Analise as afirmativas sobre nutrição e crescimento na adolescência:

I. A recomendação de cálcio é de 1.300 mg/dia, vital para o pico de massa óssea.

II. O estirão puberal e a menarca aumentam o risco de ferropenia.

III. A suplementação profilática de vitamina D é de 600 a 1.200 UI.

IV. A privação de sono prejudica o pico noturno de secreção do hormônio do crescimento.

Quantas estão corretas?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

9. (Adolescência) Analise as afirmativas sobre comportamento e mídias:

I. O bullying é violência sistemática e está associado a ansiedade, isolamento e suicídio.

II. O uso problemático de mídias interativas favorece sedentarismo, obesidade e ansiedade ligada ao medo de ficar de fora (FOMO).

III. No transtorno do jogo, a orientação central é proibir definitivamente qualquer uso de telas.

IV. Recomenda-se desligar as telas 2 horas antes de dormir, para permitir a regulação da melatonina.

Estão corretas:

A. I e III apenas.
B. II e III apenas.
C. I, II e IV apenas.
D. I, II, III e IV.

10. (Crescimento) Menino de 14 anos, pré-púbere (G1 P1), estatura no percentil 3, velocidade de crescimento normal para a idade óssea, que é de 11 anos e 6 meses. A mãe teve a menarca aos 16 anos. Estatura alvo no percentil 50. A conduta mais adequada é:

A. Acompanhar, explicando que a puberdade e o estirão ocorrerão mais tarde e que a estatura final deve atingir o alvo familiar.
B. Iniciar hormônio do crescimento.
C. Investigar tumor do sistema nervoso central com urgência.
D. Iniciar análogo de GnRH.

11. (Puberdade precoce) Menina de 5 anos com telarca e sangramento vaginal de início abrupto, sem aceleração prévia do crescimento. LH e FSH suprimidos e estradiol elevado. Ultrassonografia pélvica com cisto ovariano volumoso. Assinale a correta:

A. É puberdade precoce central idiopática; iniciar leuprorrelina.
B. O teste de estímulo com GnRH mostrará resposta puberal de LH.
C. A relação LH/FSH acima de 1 confirma o diagnóstico.
D. É puberdade precoce periférica, independente de gonadotrofinas; o tratamento é da causa de base, e o análogo de GnRH não está indicado.

12. (Hepatoesplenomegalia, fácil) Na propedêutica inicial de uma criança com hepatoesplenomegalia, o método de imagem de primeira escolha é:

A. Ressonância magnética de abdome.
B. Ultrassonografia abdominal.
C. Cintilografia hepatobiliar.
D. Colangiografia.

13. (Hepatoesplenomegalia, média) Lactente de 4 semanas, a termo, com icterícia desde a 2ª semana, fezes esbranquiçadas (acolia), urina escura e hepatomegalia de consistência aumentada. Bilirrubina direta elevada. A principal hipótese é:

A. Atresia de vias biliares.
B. Icterícia fisiológica do recém-nascido.
C. Esferocitose hereditária.
D. Doença de Gaucher.

14. (Hepatoesplenomegalia, difícil) Criança de 6 anos com anemia desde o 1º ano de vida, episódios de icterícia leve durante infecções e esplenomegalia. A mãe foi esplenectomizada na adolescência. Reticulócitos de 9%, bilirrubina indireta aumentada, Coombs direto negativo e teste de fragilidade osmótica com diminuição da resistência osmótica. O mecanismo da esplenomegalia e o diagnóstico são:

A. Infiltração por células de depósito; doença de Niemann-Pick.
B. Congestão por hipertensão portal; cirrose.
C. Hipertrofia funcional por destruição de hemácias; esferocitose hereditária.
D. Proliferação neoplásica; leucemia mieloide crônica.

15. (IVAS isolada) Criança de 2 anos, 12 kg, com febre de 38,2 °C, coriza, conjuntivite, tosse e pequenas placas nas amígdalas, linfonodos cervicais pequenos e indolores. A prescrição adequada é:

A. Dipirona 500 mg/mL, 9 gotas até de 6 em 6 horas se dor ou febre, e hidratação oral frequente.
B. Penicilina G benzatina 600.000 UI intramuscular.
C. Amoxicilina com clavulanato por 10 dias.

D. Dipirona 500 mg/mL, 30 gotas até de 6 em 6 horas.

16. (IVAS com otite) Escolar de 6 anos com febre de 39 °C, dor de garganta, amígdalas com exsudato, linfonodo cervical anterior doloroso, sem tosse ou coriza, e, à otoscopia, membrana timpânica esquerda abaulada. Sem alergias. A opção que trata adequadamente os dois quadros é:

A. Penicilina G benzatina em dose única.
B. Amoxicilina 50 mg/kg/dia por 10 dias.
C. Apenas sintomáticos, pois ambos são virais.
D. Azitromicina por 3 dias.

17. (Meningite) Escolar de 8 anos com febre, cefaleia, vômitos e rigidez de nuca, em bom estado geral. LCR límpido, 150 células por mm^3 com predomínio de mononucleares, glicose normal e proteína levemente aumentada. A interpretação e a conduta são:

A. Meningite bacteriana; ceftriaxona por 14 dias.
B. Meningite tuberculosa; esquema específico imediato.
C. Encefalite herpética; aciclovir obrigatório.
D. Meningite viral, provavelmente por enterovírus; tratamento de suporte, pois não há antiviral específico.

18. (Meningite) Analise as afirmativas sobre o tratamento da meningite bacteriana:

I. A dexametasona é usada na dose de 0,15 mg/kg de 6 em 6 horas, por 2 a 4 dias.

II. O benefício do corticoide é a redução da perda auditiva nas meningites por Hib e pneumococo.

III. O resultado do Gram autoriza a mudança do esquema antibiótico.

IV. A prevenção da hiponatremia por secreção inapropriada do hormônio antidiurético faz parte do tratamento de suporte.

Estão corretas:

A. I e III apenas.
B. II e III apenas.
C. I, II e IV apenas.
D. I, II, III e IV.

19. (Pele) Criança de 2 anos com lesões eczematosas muito pruriginosas nas fossas antecubitais e poplíteas, pele seca e rinite alérgica. Sobre o tratamento, assinale a correta:

A. Hidratantes à base de ureia são a primeira escolha.
B. Hidratação da pele, corticoide tópico nas crises e evitar banhos quentes, buchas e corticoide sistêmico.
C. Corticoide oral prolongado é o tratamento de base.
D. Banhos longos e quentes com sabonete perfumado ajudam a remover as crostas.

20. (Pele) Escolar de 7 anos com placa dolorosa, inflamada e com pústulas no couro cabeludo, com pelos que se desprendem facilmente. Exame micológico direto positivo. A conduta é:

A. Antifúngico sistêmico (por exemplo, griseofulvina), por 6 a 8 semanas ou mais.

B. Cetoconazol creme por 4 semanas.
C. Permetrina 1% loção.
D. Mupirocina tópica por 7 dias.

21. (Exantemática com esplenomegalia) Adolescente com febre há 10 dias, exantema maculopapular, amigdalite, adenopatia generalizada e hepatoesplenomegalia. Hemograma com linfocitose e 25% de linfócitos atípicos. O exame específico para confirmar a hipótese principal é:

A. Antiestreptolisina O.
B. Teste do látex no líquor.
C. Mielograma.
D. Anticorpos anti-VCA (antígeno do capsídeo viral) IgM e IgG para o vírus Epstein-Barr.

22. (Exantemática) Analise as afirmativas sobre o sarampo:

I. As manchas de Koplik surgem na mucosa jugal, próximas aos pré-molares, e são patognomônicas.

II. O exantema é céfalo-caudal e surge por volta do 3º ao 4º dia de febre.

III. Febre que persiste após o 3º dia de exantema sugere complicação bacteriana, como otite ou pneumonia.

IV. A vacinação de bloqueio pode ser feita até 72 horas após a exposição, e a imunoglobulina, até 6 dias.

Quantas estão corretas?

A. 2
B. 3
C. 4
D. Nenhuma

23. (Bronquiolite) Analise as afirmativas sobre a bronquiolite viral aguda:

I. O agente mais frequente é o vírus sincicial respiratório.

II. Broncodilatadores, corticoides e fisioterapia respiratória não são recomendados.

III. Oxigênio está indicado quando a SatO2 estiver abaixo de 92%.

IV. Lactentes abaixo de 3 meses e com apneia têm critério de internação.

Estão corretas:

A. I, II, III e IV.
B. I e II apenas.
C. III e IV apenas.
D. I, III e IV apenas.

24. (Coqueluche) Sobre o uso de antibiótico na coqueluche, assinale a correta:

A. Na fase de convalescença, o antibiótico reduz a duração da tosse.
B. A droga de escolha é a amoxicilina.

C. O hemograma típico mostra leucocitose com linfócitos atípicos acima de 20%.
D. Na fase catarral, o antibiótico diminui sinais e sintomas; na paroxística, limita a disseminação.

25. (Pneumonia) Criança de 2 anos internada por pneumonia com tiragem subcostal e dificuldade para ingerir líquidos, sem derrame, sem suspeita de estafilococo ou atípicos. O antibiótico de primeira escolha é:

A. Oxacilina associada a ceftriaxona.
B. Ampicilina endovenosa 200 mg/kg/dia de 6 em 6 horas.
C. Azitromicina oral por 5 dias.
D. Amoxicilina oral em dose habitual.

26. (Hemograma misturado) Criança de 8 anos com anemia falciforme apresenta palidez intensa e queda da Hb de 8 para 4 g/dL. Uma semana antes, teve eritema intenso nas bochechas. Reticulócitos de 0,2%. A interpretação correta é:

A. Crise hemolítica com resposta medular aumentada.
B. Sequestro esplênico com reticulocitose.
C. Crise aplásica transitória por parvovírus B19, com anemia hiporregenerativa; a conduta é transfusão de concentrado de hemácias.
D. Anemia ferropriva com reticulócitos elevados.

27. (Prescrição) Criança de 20 kg com impetigo extenso. Prescrição de cefalexina 250 mg/5 mL, 50 mg/kg/dia, de 6 em 6 horas. O volume por dose é:

A. 5 mL.
B. 2,5 mL.
C. 10 mL.
D. 20 mL.

28. (Sinusite) Escolar de 6 anos com IVAS há 6 dias. Estava melhorando, mas nas últimas 48 horas voltou a ter febre, a tosse piorou e a secreção nasal aumentou. A conduta é:

A. Sintomáticos, pois só se pensa em sinusite bacteriana após 10 dias.
B. Tomografia de seios da face antes de qualquer conduta.
C. Penicilina G benzatina.
D. Amoxicilina, pois a dupla piora caracteriza sinusite bacteriana.

29. (Exantemática) Sobre a doença de Kawasaki, assinale a correta:

A. O exantema é sempre vesicular e o principal achado diagnóstico.
B. As plaquetas costumam estar normais na 1ª semana e aumentam na 2ª e 3ª semanas; a imunoglobulina deve ser feita até o 10º dia de febre.
C. O tratamento de escolha é a penicilina, porque a doença é estreptocócica.
D. O AAS é contraindicado em qualquer fase.

30. (Hemograma) Monocitose exuberante e isolada pode ser encontrada em:

A. Asma e rinite alérgica.
B. Uso de adrenalina e corticoide.

C. Tuberculose, calazar e endocardite subaguda.

D. Neutropenia cíclica por mutação do ELANE.

Gabarito comentado do Simulado B

1 A	2 D	3 C	4 B	5 A	6 C	7 B	8 D	9 C	10 A
11 D	12 B	13 A	14 C	15 A	16 B	17 D	18 C	19 B	20 A
21 D	22 C	23 A	24 D	25 B	26 C	27 A	28 D	29 B	30 C

1. **A.** Plano B não terminado: a criança só sai reidratada. Persistindo desidratada sem gravidade, mantém-se a reidratação e, se necessário, gastróclise; Plano C só com sinais de gravidade. Antidiarreicos não devem ser usados. (Capítulo 8)
2. **D.** Menor de 1 ano: 30 mL/kg em 1 hora (210 mL) e 70 mL/kg em 5 horas (490 mL). A alternativa B é o tempo para quem tem 1 ano ou mais. (Capítulo 8)
3. **C.** Abaixo de 5 anos não há espirometria confiável; exigem-se os três critérios (sibilância recorrente, ausência de alternativa, resposta ao tratamento). (Capítulo 6)
4. **B.** No D (disability) avaliam-se consciência, pupilas e glicemia, como no caso Miguel (glicemia 86 mg/dL). (Capítulo 7)
5. **A.** Sinais de hipertensão intracraniana contraindicam a punção sem tomografia prévia; o antibiótico não deve ser atrasado. (Capítulos 9 e 14)
6. **C.** O sigilo é garantido ao adolescente com capacidade de compreender e refletir sobre suas decisões, exceto em risco à vida; o preservativo é o único método que protege contra IST. (Capítulo 13)
7. **B.** Tecido adiposo mole e difuso em adolescente obeso: lipomastia. Ginecomastia verdadeira é disco glandular firme subareolar. (Capítulo 13)
8. **D.** As quatro afirmativas estão na aula: cálcio de 1.300 mg, ferro (estirão e menarca), vitamina D de 600 a 1.200 UI e sono para o pico de GH. (Capítulo 13)
9. **C.** III está errada: no PIMU e no transtorno do jogo o objetivo é autorregulação e supervisão ativa, não abstinência absoluta. (Capítulo 13)
10. **A.** Idade óssea atrasada, velocidade normal, alvo normal e história familiar de puberdade tardia: atraso constitucional. Conduta expectante e acolhimento da ansiedade familiar. (Capítulo 13)
11. **D.** Gonadotrofinas suprimidas com estradiol alto e cisto ovariano: periférica (independente de gonadotrofinas); tratar a causa. O análogo de GnRH não atua, porque o eixo não é a origem. (Capítulo 13)
12. **B.** A ultrassonografia abdominal integra a propedêutica inicial; as demais são da sequencial. (Capítulo 10)
13. **A.** Colestase neonatal com acolia, colúria e fígado endurecido: atresia de vias biliares (obstrução biliar). Icterícia fisiológica é indireta e não causa acolia. (Capítulo 10)
14. **C.** Hemólise crônica (reticulocitose, bilirrubina indireta, Coombs negativo), herança familiar com esplenectomia e diminuição da resistência osmótica: esferocitose; o baço cresce por hipertrofia funcional ao destruir hemácias. (Capítulos 1 e 10)
15. **A.** Abaixo de 3 anos com coriza, conjuntivite e tosse: amigdalite viral, só sintomáticos. Dipirona 0,6 a 0,8 gota/kg/dose: 12 kg dá 7 a 10 gotas (cerca de 9). Trinta gotas seriam quase o triplo. (Capítulo 3)
16. **B.** A amoxicilina cobre o *S. pyogenes* da faringite e o *S. pneumoniae* da OMA; 10 dias atendem à faringite. A benzatina tem espectro restrito ao *S. pyogenes* e ao *T. pallidum*. (Capítulos 2 e 3)
17. **D.** LCR límpido, mononucleares, glicose normal e proteína pouco elevada, com bom estado geral: meningite viral; enterovírus é tratado com suporte. (Capítulo 9)

18. **C.** III está errada: o Gram é indicativo, mas não autoriza mudar o esquema; quem muda é a cultura. (Capítulo 9)
19. **B.** Dermatite atópica (flexuras após 2 anos, prurido, xerose, atopia): hidratação, corticoide tópico nas crises, evitar fatores de xerose, evitar corticoide sistêmico (rebote) e hidratantes com ureia. (Capítulo 12)
20. **A.** Tinea capitis com kerion: tratamento sempre sistêmico (o fungo está no folículo), por 6 a 8 semanas ou mais. (Capítulo 12)
21. **D.** Mononucleose: diagnóstico específico pelo anti-VCA IgM e IgG (ou PCR-DNA). (Capítulos 10 e 11)
22. **C.** As quatro estão corretas. (Capítulo 11)
23. **A.** Todas corretas. (Capítulo 5)
24. **D.** Catarral: reduz sintomas; paroxística: limita disseminação; convalescença: não indicado. Droga de escolha: macrolídeo (azitromicina); linfocitose com linfócitos típicos. (Capítulo 5)
25. **B.** De 2 meses a 5 anos internado, 1ª escolha é ampicilina EV 200 mg/kg/dia de 6/6 h; oxacilina com ceftriaxona fica para suspeita de *S. aureus* ou derrame. (Capítulo 4)
26. **C.** Eritema infeccioso (face esbofeteada) em falciforme: crise aplásica transitória, com reticulócitos baixos (anemia hiporregenerativa); transfusão. (Capítulos 1, 11 e 14)
27. **A.** 250 mg/5 mL = 50 mg/mL, igual à dose de 50 mg/kg/dia: 1 mL por kg por dia = 20 mL ÷ 4 = 5 mL de 6/6 h. (Capítulos 2 e 12)
28. **D.** A dupla piora (reinício da febre e piora da tosse e da secreção após melhora) é critério de sinusite bacteriana, mesmo antes de 10 dias. (Capítulo 3)
29. **B.** Plaquetas normais na 1ª semana, aumentam na 2ª e chegam à plaquetose na 3ª; IVIG 2 g/kg até o 10º dia de febre, com AAS. (Capítulo 11)
30. **C.** Monocitoses exuberantes e isoladas: doenças granulomatosas, tuberculose, calazar, endocardite subaguda, sífilis, riquétsias, leucemias, linfomas e colagenoses. (Capítulo 1)

Desempenho e plano de revisão

Acertos por prova	Leitura	O que fazer
26 a 30	Pronto para a prova	Revise apenas os comentários das questões erradas e as caixas “Como cai” da masterclass
20 a 25	Base boa, lacunas pontuais	Some os erros por tema (tabela da página inicial) e releia os capítulos com 2 ou mais erros
Abaixo de 20	Base insuficiente	Releia a masterclass na ordem do mapa da prova (adolescência, hepatoesplenomegalia, diarreia, IVAS, meningite, exantemáticas) e refaça a prova 48 horas depois

Dica final. Nas questões de “quantas afirmativas estão corretas”, julgue cada frase isoladamente e marque V ou F ao lado antes de contar; os erros mais comuns da banca estão em números trocados (8 e 9 anos, 30 e 70 mL/kg, 1 hora e 30 minutos), em nomes trocados (Pastia e Filatov, típico e atípico) e em condutas “radicais” (suspender alimentação, proibir telas, benzatina na erisipela).